BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Sağlık Öyküsü ve Sağlık Eğitimi Çalışma Notu

Gereksinim Belirleme · Hedef Yazma · Modeller · Yöntem ve Materyal · Eğitim Planı · Değerlendirme · Konu Bankası

FR.184 beceri 8, FR.185 madde 24–25 ve FR.186 madde 12 için: çocuk-ergen ve yetişkin eğitimleri nasıl planlanır, uygulanır, değerlendirilir ve kanıtlanır.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Sağlık Öyküsü ve Sağlık Eğitimi Çalışma Notu

1. EĞİTİMİN BAŞLANGICI: SAĞLIK ÖYKÜSÜ VE GEREKSİNİMİN BELİRLENMESİ

- 1.1 Eğitim gereksinimini nereden anlarım?
- 1.2 Eğitim için kısa sağlık öyküsü – neler sorulur?

2. TEMEL KAVRAMLAR

- 2.1 Sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığı
- 2.2 Öğrenme alanları ve hedef yazma
- 2.3 Hedef kitleye göre öğrenme ilkeleri

3. SAĞLIK DAVRANIŞI MODELLERİ – EĞİTİMİ NEYE DAYANDIRACAĞIM?

- 3.1 Sağlık İnanç Modeli
- 3.2 Transteorik Model (Davranış Değişikliği Aşamaları)
- 3.3 Pender'in Sağlığı Geliştirme Modeli
- 3.4 PRECEDE-PROCEED Modeli

4. YÖNTEM VE MATERYAL SEÇİMİ

- 4.1 Eğitim yöntemleri
- 4.2 Eğitim materyalleri
- 4.3 "En fazla 2 sayfalık içerik" nasıl yazılır?

5. SAĞLIK EĞİTİM PLANI NASIL YAZILIR?

- 5.1 Planın bölümleri
- 5.2 Doldurulmuş örnek plan 1 – Çocuk eğitimi: El hijyeni
- 5.3 Doldurulmuş örnek plan 2 – Ergen eğitimi: Ekran süresi, uyku ve dijital denge
- 5.4 Doldurulmuş örnek plan 3 – Yetişkin eğitimi: Hipertansiyonda tuz kısıtlaması

6. EĞİTİMİN UYGULANMASI

- 6.1 Eğitimin üç bölümü
- 6.2 Etkili eğitimin ipuçları

7. EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8. "HAFTADA EN AZ 15 KİŞİ" HEDEFİNİ TUTTURMAK VE KANITLAMAK

9. KONU BANKASI – ANAHTAR MESAJLAR

- 9.1 Çocuk ve ergen konuları
- 9.2 Yetişkin konuları

10. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – Sağlık Öyküsü ve Sağlık Eğitimi Çalışma Notu

Bu not, değerlendirme formlarında sağlık eğitimiyle ilgili tüm maddelere hazırlanman için yazıldı:

- **FR.184 beceri 8:** "Bireyden **yeterli sağlık öyküsünü alabilme** ve **bireye özgü sağlık eğitimini planlayabilme**"
- **FR.185 madde 24 (8 puan):** "ASM'ye başvuran **çocuk ve ergenlere** yönelik ihtiyaç görülen konularda eğitim yapmak (**her öğrenci her hafta en az 15 kişi**) (ihtiyaç görülen konuya uygun **sağlık eğitim planı**, verilen eğitime dair **en fazla 2 sayfalık içerik ve materyal** oluşturarak) (fotoğraflarla kanıtlayarak)"
- **FR.185 madde 25 (8 puan):** Aynı koşullarla **yetişkinlere** yönelik eğitim
- **FR.186 madde 12 (8 puan):** "ASM'de saha çalışmasına çıkılan **her gün** gerekli görülen konuda **en az 1 eğitim** yapmak (fotoğraflar ve eğitim materyalleri ile kanıtlayarak) (**bireye özgü eğitim planı oluşturma, uygulama ve eğitimin değerlendirmesi**)"

Kanser tarama eğitimleri ayrı bir notta anlatıldı; bu not **çocuk-ergen ve yetişkin eğitimlerinin** nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve değerlendirileceğini, sonunda da konu konu **anahtar mesajları** anlatır.

Formların sağlık eğitiminden beklediği beş şey şunlardır: **(1) gereksinime dayalı bir sağlık eğitim planı, (2) en fazla 2 sayfalık içerik, (3) en az bir materyal, (4) eğitimin uygulanması ve değerlendirilmesi, (5) izinli fotoğraflarla kanıt.**

---

1. EĞİTİMİN BAŞLANGICI: SAĞLIK ÖYKÜSÜ VE GEREKSİNİMİN BELİRLENMESİ

"Bireye özgü" eğitim, bireyi tanımadan yapılamaz. Bu yüzden her eğitim, kısa da olsa bir **öykü ve gereksinim belirleme** ile başlar. Formdaki "**ihtiyaç görülen konularda**" ifadesi de bunu anlatır: Eğitimin konusu rastgele değil, **bir gereksinime dayanarak** seçilmelidir.

1.1 Eğitim gereksinimini nereden anlarım?

- **Kişinin kendi isteği ve soruları:** "Bebeğime ne zaman ek gıda başlayayım?", "Şekerim neden düşmüyor?"
- **Öyküde saptanan sorunlar ve riskler:** Sigara içiyor, hareketsiz, ilaçlarını düzensiz kullanıyor, tuzlu besleniyor.
- **Ölçüm ve gözlemler:** Kan basıncı yüksek, BKİ 31, çocukta çürük dişler, ergenin ekran süresi uzun, annenin emzirme tekniği yanlış.
- **İzlem dönemi:** Her izlemin kendine özgü eğitim konuları vardır (6. ayda ek gıda, 28. haftada bebek hareketi sayımı, 12. ayda kaza önleme).
- **ASM verileri:** Bölgede sık görülen sorunlar (kayıtlı nüfusta hipertansiyon ve obezite yaygınsa bu konular öncelikli).
- **Ön test:** Eğitim öncesinde sorulan birkaç soruyla bilgi düzeyi ölçülür.

1.2 Eğitim için kısa sağlık öyküsü – neler sorulur?

ASM'de bir eğitim öncesinde birkaç dakikalık bir görüşmeyle şunları öğrenmeye çalış:

1. **Kimlik ve özellikler:** Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, okuryazarlık, meslek, kiminle yaşadığı.
2. **Sağlık durumu:** Kronik hastalık, kullandığı ilaçlar, alerji, gebelik/emzirme.
3. **Sağlık davranışları:** Beslenme, fiziksel aktivite, uyku, sigara-alkol, ekran süresi (çocuk ve ergende), diş fırçalama, el yıkama.
4. **Koruyucu sağlık hizmetleri:** Aşılar, izlemler, taramalar.
5. **Konuyla ilgili bilgi ve inançlar:** "Bu konuda ne biliyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz?" (Yanlış inanışlar burada ortaya çıkar.)
6. **Davranışı değiştirmeye hazır oluşu:** "Bu konuda bir şeyleri değiştirmeyi düşünüyor musunuz?"
7. **Engeller ve destekler:** Zaman, maddi olanak, aile desteği, ulaşım.
8. **Öğrenme tercihi:** Okumayı mı, görerek mi, yaparak mı daha iyi öğreniyor? Gözlük ya da işitme cihazı kullanıyor mu?

Bu bilgiler eğitimin **içeriğini, dilini, yöntemini ve materyalini** belirler. Örneğin okuma yazma bilmeyen bir yaşlıya yazılı broşür yerine resimli kart ve gösterim; ergen bir kıza grup tartışması yerine bireysel ve gizli bir görüşme daha uygundur.

---

2. TEMEL KAVRAMLAR

2.1 Sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığı

Sağlık eğitimi, bireylerin, ailelerin ve toplulukların sağlıkla ilgili **bilgi, tutum ve davranışlarında** olumlu değişiklikler oluşturmak amacıyla **planlı öğrenme deneyimleri** sunma sürecidir. Amaç yalnızca bilgi vermek değil, kişinin **sağlıklı davranışı benimsemesini ve sürdürmesini** sağlamaktır.

Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlıkla ilgili bilgiye **ulaşma, onu anlama, değerlendirme ve kullanma** becerisidir. Toplumumuzda sağlık okuryazarlığı yetersiz olan kişilerin oranı yüksektir. Bu yüzden eğitimde **sade dil, kısa cümleler, görsel materyal, gösterip yaptırma ve öğret-geri al yöntemi** kullanılmalıdır.

2.2 Öğrenme alanları ve hedef yazma

Öğrenme üç alanda gerçekleşir (Bloom):

- **Bilişsel alan (bilgi):** Bilmek, anlamak, uygulamak, analiz etmek. Hedef fiilleri: **sayar, tanımlar, açıklar, örnek verir, ayırt eder, hesaplar.**
- **Duyuşsal alan (tutum, değer, istek):** Bir şeyi önemseme, kabul etme, istekli olma. Hedef fiilleri: **önemini ifade eder, niyetini belirtir, kabul eder, istekli olduğunu gösterir.**
- **Psikomotor alan (beceri):** Bir işi elleriyle doğru yapabilme. Hedef fiilleri: **gösterir, uygular, yapar, ölçer.**

Hedef yazma kuralları:

- Hedef, **eğitimi alan kişi açısından** yazılır: "Eğitim sonunda katılımcı ..."
- **Ölçülebilir bir fiil** kullanılır. "Öğrenir, bilir, anlar, kavrar, farkında olur, bilgilenir" fiilleri ölçülemez, kullanılmaz.
- Mümkünse **ölçüt** içerir: "en az üç", "yedi adımın tamamını".
- Her eğitimde **üç alandan** en az birer hedef olması iyi bir uygulamadır.

Örnek hedefler (çocuklara el hijyeni eğitimi):

- Bilişsel: "Öğrenci el yıkaması gereken en az dört durumu sayar."
- Duyuşsal: "Öğrenci yemekten önce el yıkamaya istekli olduğunu ifade eder."
- Psikomotor: "Öğrenci yedi adımda el yıkamayı 20 saniye boyunca doğru uygular."

Örnek hedefler (hipertansiyonlu yetişkine tuz eğitimi):

- Bilişsel: "Katılımcı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğini ve gizli tuz içeren en az beş besini sayar."
- Duyuşsal: "Katılımcı sofradan tuzluğu kaldırmaya niyetli olduğunu ifade eder."
- Psikomotor: "Katılımcı bir besin etiketinde tuz/sodyum miktarını doğru gösterir."

2.3 Hedef kitleye göre öğrenme ilkeleri

Yetişkinler (andragoji):

- Bir şeyi **neden öğrenmesi gerektiğini** bilmek ister → konuyu kendi yaşamı ve sağlığıyla ilişkilendir ("Bu tansiyon değerleriyle inme riskiniz artıyor").
- **Deneyimlerini** öğrenmeye katar → "Siz bu konuda neler yapıyorsunuz?" diye sorarak başla, deneyimlerini kullan.

- **Sorun odaklı ve hemen işe yarayan** bilgi ister → teoriden çok "ne yapmalıyım"a odaklan.
- **Kendi kararlarını vermek** ister → öğüt vermek yerine seçenekleri sun, kararı ona bırak.
- **İçsel motivasyon** daha güçlüdür → torunlarıyla zaman geçirmek, işini sürdürmek, bağımsız kalmak gibi kişisel nedenleri kullan.

Yaşlılar:

- Yavaş tempo, kısa oturum, sık tekrar, **büyük puntolu** materyal, iyi aydınlatılmış ve sessiz ortam.
- Görme ve işitme kayıpları dikkate alınır (gözlük, işitme cihazı takılı mı? Yüzüne bakarak, net ve alçak tonla konuş).
- Bir kerede tek konu; yazılı özet; gerekirse bakım veren de eğitime katılır.

Okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklar:

- Somut düşünürler; soyut kavramlar yerine **somut örnekler, resimler, oyun, şarkı, kukla, boyama ve gösterip yaptırma** kullanılır.
- Dikkat süresi kısadır: **10–20 dakika**, tek bir ana mesaj.
- Övgü ve küçük ödüller (çıkartma) davranışı pekiştirir.
- Ebeveynlerin de bilgilendirilmesi davranışın evde sürmesini sağlar.

Ergenler:

- Soyut düşünebilir, tartışabilir; **grup tartışması, vaka örnekleri, rol oyunu, akran eğitimi, gerçek yaşamdan senaryolar** etkilidir.
- **Yargılamayan, öğüt vermeyen** bir dil kullanılır; ergenin kimlik ve özerklik ihtiyacına saygı gösterilir.
- **Mahremiyet** önemlidir; hassas konular (cinsellik, madde, ruh hali) bireysel ve gizlilik içinde konuşulur.
- Kısa vadeli sonuçlar (görünüm, spor performansı, arkadaşlar) uzun vadeli sağlık risklerinden daha etkileyicidir: "Sigara dişlerini sarartır, nefesini koku yapar, maçta çabuk yorulursun."

---

3. SAĞLIK DAVRANIŞI MODELLERİ – EĞİTİMİ NEYE DAYANDIRACAĞIM?

Modeller, kişinin neden bir davranışı yapıp yapmadığını açıklar ve eğitimi **bilimsel bir temele** oturtur. Eğitim planında "kuramsal temel" olarak bir modeli belirtmek planın kalitesini artırır.

3.1 Sağlık İnanç Modeli

Kişi bir sağlık davranışını şu koşullarda yapar:

- **Algılanan duyarlılık:** "Bu hastalık benim de başıma gelebilir."
- **Algılanan ciddiyet:** "Bu hastalık ciddi sonuçlar doğurur."
- **Algılanan yarar:** "Bu davranış beni korur."
- **Algılanan engeller:** "Bu davranışı yapmak zor/pahalı/zaman alıcı/korkutucu" – engeller ne kadar azsa davranış o kadar olasıdır.
- **Harekete geçirici uyaranlar:** Bir hatırlatma, bir tanıdığın hastalanması, sağlık çalışanının önerisi.
- **Öz-etkililik:** "Ben bunu yapabilirim" inancı.

Eğitimde kullanımı: Kişinin duyarlılık ve ciddiyet algısını gerçekçi bilgiyle artır, yararları somut olarak göster, engelleri birlikte konuş ve çözüm üret, uyaran sağla (randevuyu o an ver, hatırlatıcı kur), beceriyi uygulatarak öz-etkililiği artır.

3.2 Transteorik Model (Davranış Değişikliği Aşamaları)

Davranış değişikliği bir anda değil, aşamalarla olur:

1. **Düşünmeme:** Kişi önümüzdeki 6 ay içinde değişmeyi düşünmüyor; çoğu zaman sorunun farkında değil ya da önemsemiyor. → **Farkındalık oluştur**, kişisel riskleri ve yararları anlat, yargılama, kapıyı açık bırak.
2. **Düşünme:** Değişmeyi düşünüyor ama kararsız. → **Artıları ve eksileri** birlikte tart, kararsızlığı konuş, cesaretlendir.
3. **Hazırlık:** Yakın zamanda (bir ay içinde) değişmeye karar vermiş. → **Somut plan** yap (bırakma tarihi, yürüyüş saati), küçük adımlar belirle.
4. **Hareket:** Davranışı değiştirmiş (6 aydan kısa süredir). → **Destekle, öv**, zorlukları konuş, nüksü önleme yollarını planla.
5. **Sürdürme:** Davranışı 6 aydan uzun süredir sürdürüyor. → **Pekiştir**, nüks risklerini hatırlat. Nüks (eski davranışa dönüş) sürecin doğal bir parçası olabilir; kişi suçlanmadan yeniden aşamalara dahil edilir.

Eğitimde kullanımı: Aynı konuda bile kişinin aşamasına göre farklı eğitim yapılır. Düşünmeme aşamasındaki bir sigara içicisine "Yarın bırakın" demek işe yaramaz; önce farkındalık oluşturmak gerekir.

3.3 Pender'in Sağlığı Geliştirme Modeli

Kişinin geçmiş deneyimleri ve bireysel özellikleri, davranışa ilişkin **algılanan yarar ve engeller**, **öz-etkililik**, davranışla ilgili **duygular**, **kişilerarası etkiler** (aile, arkadaş desteği) ve **durumsal etkiler** (ortam, olanaklar) sağlığı geliştirici davranışı belirler. Özellikle beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi gibi **sağlığı geliştirme** eğitimlerinde kullanılır.

3.4 PRECEDE-PROCEED Modeli

Eğitimi planlarken davranışı etkileyen üç tür etkene bakılır:

- **Hazırlayıcı etkenler:** Bilgi, tutum, inanç, değerler.
- **Kolaylaştırıcı etkenler:** Beceriler, kaynaklar, hizmetlere erişim.
- **Pekiştirici etkenler:** Aile, arkadaş, sağlık çalışanlarının desteği ve geri bildirimi. Özellikle **grup ve toplum eğitimlerinde** (okul, kurum) kullanılır.

---

4. YÖNTEM VE MATERYAL SEÇİMİ

4.1 Eğitim yöntemleri

- **Bireysel görüşme ve danışmanlık:** ASM'de kişiye özgü gereksinimlerde, hassas konularda en uygun yöntem. Eğitim tamamen kişiye göre şekillenir.
- **Anlatım ve soru-cevap:** Kısa bilgi aktarımı için; bekleme salonundaki küçük gruplarda. Anlatım tek başına uzun tutulmamalı, sık sık soru sorularak katılım sağlanmalıdır.
- **Gösterip yaptırma (demonstrasyon): Beceri öğretiminde en etkili yöntem.** Önce eğitici gösterir, sonra katılımcı yapar, eğitici düzeltir. El yıkama, diş fırçalama, insülin uygulama, inhaler kullanımı, emzirme, KKMM, kan basıncı ölçümü bu yöntemle öğretilir.
- **Grup tartışması:** Ergen, veli ve çalışan gruplarında; katılımcıların deneyim ve görüşlerini paylaşması.
- **Rol oyunu ve vaka çalışması:** Ergenlerde akran baskısına hayır deme, iletişim becerileri.
- **Oyun, şarkı, hikâye, kukla, boyama:** Okul öncesi ve ilkokul çocukları.
- **Beyin fırtınası:** Grup içinde bir soruna çözüm üretme.

4.2 Eğitim materyalleri

Formda "**en az 1 materyal**" isteniyor. Materyal, eğitimi destekler ama eğitimin yerine geçmez.

- **Broşür/el ilanı:** Kişi eve götürür. İyi bir broşür: tek bir konu; dikkat çekici başlık; **büyük punto (en az 12–14)**; kısa ve sade cümleler; tıbbi terim yerine günlük sözcükler; **"ne yapmalıyım?" odaklı** mesajlar; konuyu anlatan **resimler**; başvuru yerleri ve telefon numaraları (ASM, 112, ALO 171 gibi).
- **Poster/afiş:** Uzaktan okunabilen kısa başlık, tek mesaj, güçlü görsel; bekleme salonu ya da sınıf duvarı için.
- **Maket:** Diş maketi ve büyük fırça, meme maketi, bebek maketi, insülin kalemi, inhaler örneği. **Beceri öğretiminde en etkili materyal.**
- **Resimli kartlar (flip chart):** Bekleme salonunda küçük gruplar için; her kartta bir mesaj ve resim.
- **Gerçek nesneler:** 5 gram tuzun çay kaşığında gösterilmesi; bir kutu kola ya da hazır meyve suyundaki şekerin küp şekerle gösterilmesi; ilaç kutusu; besin etiketleri.
- **Slayt sunumu:** Okul ya da kurumdaki gruplar için; az yazı, çok görsel; tek başına okunmaz, anlatımı destekler.
- **Video ve dijital materyal:** Kısa (2–3 dakikalık) ve güvenilir kaynaklı.
- **Çocuklar için:** Kukla, boyama sayfası, çıkartma, el yıkama şarkısı, oyun kartları.

4.3 "En fazla 2 sayfalık içerik" nasıl yazılır?

FR.185 madde 24 ve 25, her eğitim için **en fazla iki sayfalık içerik** istiyor. Bu içerik, eğitimde anlattıklarının yazılı özetidir ve broşür ya da bilgi notu olarak da kullanılabilir. Nasıl yazılır?

- **Başlık:** Konuyu ve hedef kitleyi belli eden kısa bir başlık ("Ergenlikte Sağlıklı Beslenme", "Tansiyonunuzu Tuzla Yükseltmeyin").
- **Giriş (2–3 cümle):** Konunun neden önemli olduğu, kişiyi neden ilgilendirdiği.
- **Ana bölüm (3–5 alt başlık):** Her alt başlıkta kısa paragraflar ya da maddeler. Örneğin: "... nedir?", "Neden önemlidir?", "Neler yapmalısınız?", "Nelerden kaçınmalısınız?", "Ne zaman başvurmalısınız?"
- **Uygulanabilir öneriler:** Somut, ölçülebilir öneriler ("günde en az 60 dakika", "günde 2 kez 2 dakika", "1 silme çay kaşığı").
- **Başvuru bilgisi:** Nereye başvurulacağı (ASM, 112, ilgili danışma hatları).
- **Kaynak:** Güvenilir kaynaklar (Sağlık Bakanlığı rehberleri, Türkiye Beslenme Rehberi vb.).

- **Dil:** Hedef kitleye uygun; çocuklar ve ergenler için hitap eden, sade ve olumlu dil; yaşlılar için büyük punto ve kısa cümleler.
- **İki sayfayı aşmamak** formdaki kurala uymak demektir; daha uzun yazmak artı değil eksi puan getirebilir.

---

5. SAĞLIK EĞİTİM PLANI NASIL YAZILIR?

5.1 Planın bölümleri

Her eğitim için hazırlanacak planda şu başlıklar bulunur:

1. **Eğitimin konusu**
2. **Eğitimin türü:** Bireysel ya da grup; çocuk-ergen / yetişkin / genel.
3. **Hedef kitle:** Yaş, cinsiyet, özellikler, kişi sayısı.
4. **Gereksinimin belirlenmesi:** Bu konunun neden seçildiği (öykü, gözlem, ölçüm, ön test, ASM verisi).
5. **Yer, tarih, süre.**
6. **Eğitimi veren.**
7. **Kuramsal temel (isteğe bağlı ama önerilir):** Sağlık İnanç Modeli, Transteorik Model vb.
8. **Genel amaç.**
9. **Öğrenme hedefleri:** Bilişsel, duyuşsal, psikomotor.
10. **İçerik:** Ana başlıklar.
11. **Yöntem.**
12. **Materyal.**
13. **Eğitimin akışı:** Giriş, gelişme, sonuç bölümleri ve süreleri.
14. **Değerlendirme:** Yöntem (ön-son test, geri gösterim, soru-cevap, gözlem) ve sonuç.
15. **Omaha kaydı:** Problem – girişim – Bilgi/Davranış/Durum.
16. **Kaynaklar.**

5.2 Doldurulmuş örnek plan 1 – Çocuk eğitimi: El hijyeni

- **Konu:** El yıkama ve mikroplardan korunma
- **Tür:** Grup eğitimi – çocuk
- **Hedef kitle:** ASM'ye aşı ve izlem için gelen 5–9 yaş arası 5 çocuk ve ebeveynleri
- **Gereksinim:** Bekleme salonunda gözlemlenen çocukların tuvaletten sonra ellerini yıkamadığı görüldü; ebeveynler son haftalarda çocuklarında ishal olduğunu belirtti.
- **Yer, süre:** ASM bekleme salonu, 10 dakika
- **Kuramsal temel:** Öz-etkililik (gösterip yaptırma ile "yapabilirim" duygusu)
- **Genel amaç:** Çocukların doğru el yıkama alışkanlığı kazanması
- **Hedefler:** Eğitim sonunda çocuk; el yıkaması gereken en az dört durumu sayar (bilişsel); yemekten önce el yıkamak istediğini söyler (duyuşsal); yedi adımda el yıkamayı 20 saniye boyunca doğru uygular (psikomotor).
- **İçerik:** Mikroplar gözle görülmez ama ellerimizde bulunur; mikroplar ellerimizden ağzımıza ve arkadaşlarımıza geçer; el yıkama zamanları (tuvaletten sonra, yemekten önce, oyundan sonra, öksürüp hapşırdıktan sonra, hayvanlara dokunduktan sonra); yedi adımda el yıkama; ellerin temiz havluyla kurulanması.
- **Yöntem:** Kısa hikâye anlatımı, soru-cevap, gösterip yaptırma, şarkı
- **Materyal:** Resimli yedi adım el yıkama posteri, el yıkama şarkısı, simli krem (mikropların nasıl yayıldığını göstermek için), çıkartma
- **Akış:** *Giriş (2 dk):* Kendimi tanıtıp "Mikropları hiç gördünüz mü?" sorusuyla başlarım; simli kremi bir çocuğun eline sürüp diğer çocuklarla tokalaşmasını isterim, simlerin herkese bulaştığını gösteririm. *Gelişme (6 dk):* El yıkama zamanlarını resimlerle anlatırım; yedi adımı posterle gösterip şarkı eşliğinde birlikte "havada" yaparım; lavaboda her çocuğa uygulatırım. *Sonuç (2 dk):* "Ne zaman el yıkıyoruz?" diye sorarım; doğru yapanlara çıkartma veririm; ebeveynlere evde de hatırlatmalarını söylerim.

- **Değerlendirme:** Her çocuğa yedi adımı uygulatıp kontrol listesiyle değerlendirme; el yıkama zamanlarını sorma. *Sonuç örneği:* 5 çocuğun 4'ü yedi adımı doğru uyguladı, 1'i başparmaklarını atladı ve tekrar gösterildi; çocukların tamamı en az üç el yıkama zamanını saydı.
- **Omaha:** Fizyolojik – Bulaşıcı/enfeksiyöz durum – Toplum (çocuk grubu) – Potansiyel (risk: yetersiz el hijyeni) · Sağlık eğitimi – Enfeksiyondan korunma önlemleri; Sağlık eğitimi – Kişisel hijyen; Tedaviler ve işlemler – Enfeksiyondan korunma önlemleri (uygulatma); Gözetim – bir sonraki izlemde el yıkama alışkanlığının sorulması · Bilgi 2 → 4, Davranış 2 → 4, Durum 4 → 4

5.3 Doldurulmuş örnek plan 2 – Ergen eğitimi: Ekran süresi, uyku ve dijital denge

- **Konu:** Ekran süresi, uyku ve dijital denge
- **Tür:** Bireysel eğitim – ergen
- **Hedef kitle:** Td aşısı için gelen 13 yaşında bir kız öğrenci
- **Gereksinim:** Görüşmede günde yaklaşık 6 saat telefon kullandığını, gece 01.00'den önce uyumadığını, sabahları okulda yorgun olduğunu söyledi.
- **Süre:** 10–12 dakika
- **Kuramsal temel:** Transteorik model (görüşmede "biraz azaltmam gerekiyor ama zor" dedi → düşünme aşaması)
- **Genel amaç:** Ergenin ekran süresini azaltması ve uyku düzenini iyileştirmesi
- **Hedefler:** Eğitim sonunda ergen; uzun ekran kullanımının en az dört sağlık etkisini sayar (bilişsel); ekran süresini azaltmaya istekli olduğunu ifade eder (duyuşsal); kendi ekran süresini telefon ayarlarından gösterir ve kendisi için iki somut hedef yazar (psikomotor).
- **İçerik:** Ekranın uykuya etkisi (mavi ışık ve zihinsel uyarılma uykuya dalmayı geciktirir); 13–18 yaş için önerilen uyku süresi (8–10 saat); uzun ekran kullanımının göz yorgunluğu, boyun-sırt ağrısı, hareketsizlik ve kilo alımı, dikkat ve ders başarısı üzerindeki etkileri; sosyal medya ve kendini başkalarıyla kıyaslama; siber zorbalık; pratik öneriler (yatmadan 1 saat önce ekranı bırakma, telefonu yatak odası dışında şarja takma, bildirimleri kapatma, ekran süresi sınırı koyma, günde en az 60 dakika fiziksel aktivite).
- **Yöntem:** Bireysel görüşme, soru-cevap, kendi telefonu üzerinde uygulama (ekran süresi raporu), hedef belirleme
- **Materyal:** İki sayfalık "Dijital Denge" bilgi notu, hedef kartı
- **Akış:** *Giriş:* Yargılamadan, merakla sorarım: "Telefonda en çok neler yapıyorsun? Sabahları nasıl uyanıyorsun?" *Gelişme:* Ekran ile uyku ve yorgunluk arasındaki bağı onun anlattıklarıyla ilişkilendiririm; telefonundaki ekran süresi raporuna birlikte bakarız; kendi hedeflerini kendisinin seçmesini isterim. *Sonuç:* Hedeflerini kartına yazar; bir sonraki görüşmede nasıl gittiğini konuşacağımızı söylerim.
- **Değerlendirme:** Soru-cevap ile dört etkiyi sayması; hedef kartı ("Gece 23.00'te telefonu salonda şarja takacağım", "Günlük sosyal medya süresini 2 saatle sınırlayacağım"); bir hafta sonra ekran süresi raporu (telefonla ya da bir sonraki başvuruda).
- **Omaha:** Sağlıkla ilgili davranışlar – Uyku ve dinlenme örüntüleri – Birey – Gerçek (belirti: yaşa uygun olmayan uyku düzeni) · Sağlık eğitimi – Dinlenme/uyku; Sağlık eğitimi – Davranış değişikliği; Gözetim – Dinlenme/uyku · Bilgi 2 → 4, Davranış 2 → 3, Durum 3 → 3

5.4 Doldurulmuş örnek plan 3 – Yetişkin eğitimi: Hipertansiyonda tuz kısıtlaması

- **Konu:** Tansiyonunuzu tuzla yükseltmeyin
- **Tür:** Bireysel eğitim – yetişkin
- **Hedef kitle:** 58 yaşında hipertansiyonlu erkek ve yemekleri hazırlayan eşi
- **Gereksinim:** KB 154/95 mmHg; yemeğe tadına bakmadan tuz ekliyor; her öğünde turşu yiyor; "Tuzsuz yemek boğazımdan geçmiyor" diyor.
- **Süre:** 15 dakika

- **Kuramsal temel:** Sağlık İnanç Modeli (algılanan ciddiyet düşük: "Tansiyon herkeste var")
- **Genel amaç:** Bireyin günlük tuz tüketimini azaltması
- **Hedefler:** Eğitim sonunda birey ve eşi; günlük tuz sınırını (5 gramın altı) ve gizli tuz içeren en az beş besini sayar (bilişsel); tuzluğu sofradan kaldırma niyetini ifade eder (duyuşsal); bir besin etiketinde tuz/sodyum miktarını gösterir (psikomotor).
- **İçerik:** Tuzun kan basıncını nasıl yükselttiği; yüksek tansiyonun belirti vermeden kalp, beyin, böbrek ve gözlere verdiği zarar; 5 gram tuzun ne kadar olduğu; gizli tuz kaynakları; tuzu azaltma yolları; tat alma duyusunun birkaç haftada az tuza alışacağı.
- **Yöntem:** Anlatım, soru-cevap, gösterim
- **Materyal:** Çay kaşığı ve 5 gram tuz, iki farklı besin etiketi (ekmek ve hazır çorba), iki sayfalık bilgi notu
- **Akış:** *Giriş:* "Tansiyon hakkında neler biliyorsunuz?" sorusuyla inançlarını öğrenirim. *Gelişme:* Hipertansiyonun sessiz ilerlediğini ve olası sonuçlarını resimli kartla anlatırım; 5 gram tuzu çay kaşığında gösteririm; ekmek, peynir, zeytin, turşu, salamura, hazır çorba, işlenmiş et, cipsin gizli tuz kaynakları olduğunu anlatırım; etiket okumayı gösteririm; tuzluğu kaldırma, yemeğe pişirme sonunda tuz ekleme, limon-sirke-nane-kekik gibi baharatlarla lezzetlendirme ve tuzu aşamalı azaltma önerilerini veririm. *Sonuç:* Kendi ağzından neleri değiştireceğini söylemesini isterim.
- **Değerlendirme:** Öğret-geri al (eşinden ve kendisinden öğrendiklerini anlatmalarını isterim); etiket üzerinde gösterme; iki hafta sonraki izlemde tuz tüketimine ilişkin beyan ve kan basıncı.
- **Omaha:** Sağlıkla ilgili davranışlar – Beslenme – Birey – Gerçek (belirti: önerilen beslenme planına uymama) ve Fizyolojik – Dolaşım · Sağlık eğitimi – Diyet yönetimi; Vaka yönetimi – Diyetisyen bakımı; Gözetim – Belirti/bulgular–fiziksel · Bilgi 2 → 4, Davranış 2 → 3, Durum 2 → (sonraki izlemde)

---

6. EĞİTİMİN UYGULANMASI

6.1 Eğitimin üç bölümü

- **Giriş (sürenin yaklaşık %10–15'i):** Selamlama ve kendini tanıtma; izin alma; **dikkat çekme** (bir soru, kısa bir hikâye, şaşırtıcı bir bilgi, bir gösterim); konunun kişi için neden önemli olduğu; eğitimin hedefleri; kişinin konuyla ilgili ne bildiğini öğrenme (ön değerlendirme).
- **Gelişme (yaklaşık %70–75'i):** En fazla **3–5 ana mesaj**; basitten karmaşığa; her mesajı bir örnekle ve materyalle destekleme; beceri varsa **gösterip yaptırma**; sık sık kişiye soru sorma ve katılımını sağlama; kişinin sorularını ve kaygılarını yanıtlama.
- **Sonuç (yaklaşık %10–15'i):** Ana mesajların **özetlenmesi**; soruların yanıtlanması; **değerlendirme** (son test, geri gösterim, öğret-geri al); **eyleme çağrı** ("Bugünden itibaren tuzluğu sofradan kaldırmayı deneyebilir misiniz?"); materyalin verilmesi; teşekkür; sonraki görüşmenin belirtilmesi.

6.2 Etkili eğitimin ipuçları

- Kişiyle **göz teması** kur, onun hızına uy, tıbbi terim kullanma.
- **Bir kerede çok fazla bilgi** verme; en önemli birkaç mesajı tekrar et.
- Olumsuz ve korkutucu mesajlar yerine **olumlu ve yapılabilir** mesajlar ver ("Şunu yapmayın" yerine "Şunu deneyin").
- Kişinin **kültürüne ve inançlarına** saygı göster; zararlı olmayan uygulamalara karışma, zararlı olanları nazikçe ve gerekçesiyle düzelt.
- **Aile üyelerini** (yemekleri hazırlayan eş, bebeğe bakan büyükanne) eğitime dahil et.
- **Öğret-geri al yöntemini** kullan: "Size doğru anlatıp anlatamadığımı kontrol etmek istiyorum; evde eşinize nasıl anlatırdınız?" Bu soru kişiyi sınamak için değil, eğiticinin kendini kontrol etmesi içindir; yanlış anlaşılan kısım yeniden ve farklı bir yolla anlatılır.

---

7. EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Formlarda "**eğitimin değerlendirmesi**" ayrıca puanlanır. Değerlendirme olmayan eğitim eksiktir.

- **Ön test – son test:** Eğitimden önce ve sonra aynı 3–5 kısa soru sorulur; doğru yanıt sayısındaki artış bilgi kazanımını gösterir. Sorular basit, açık uçlu ya da doğru-yanlış olabilir.
- **Geri gösterim ve kontrol listesi:** Beceri eğitimlerinde (el yıkama, diş fırçalama, insülin, inhaler) kişinin uygulaması, basamakları içeren bir listeyle değerlendirilir ("7 basamağın 6'sı doğru").
- **Soru-cevap ve öğret-geri al.**
- **Gözlem:** Eğitimden sonra davranışın gözlenmesi (teneffüs sonrası el yıkama).
- **Niyet ve somut adım:** Kişinin bir davranış niyetini ifade etmesi ya da somut bir adım atması (randevu alması, hedef kartı yazması).
- **İzlem:** Bir sonraki görüşmede davranışın ve sağlık göstergelerinin (KB, kilo) değişip değişmediği.
- **Katılımcı memnuniyeti:** Grup eğitimlerinde kısa geri bildirim.

Değerlendirme sonuçları **Omaha'nın Bilgi-Davranış-Durum puanlarına** dönüştürülerek kaydedilir.

---

8. "HAFTADA EN AZ 15 KİŞİ" HEDEFİNİ TUTTURMAK VE KANITLAMAK

FR.185'e göre **çocuk-ergen eğitimleri için ayrı, yetişkin eğitimleri için ayrı** olmak üzere her hafta en az 15'er kişiye eğitim vermelisin (kanser tarama eğitimi de ayrıca 15 kişi).

- **İzlemlerle birleştir:** Bebek izlemine gelen anne bir **yetişkin** eğitimi fırsatıdır (emzirme, ek gıda, kaza önleme); aşıya gelen 13 yaşındaki ergen bir **çocuk-ergen** eğitimi fırsatıdır (ergenlik, beslenme, ekran); okul çağı izlemine gelen çocuk el yıkama ve diş fırçalama eğitimi alabilir.
- **Bekleme salonunda kısa grup eğitimleri:** 3–6 kişilik gruplara 5–10 dakikalık eğitimler; günde 2–3 grup yaparsan haftalık sayıyı kolayca aşarsın.
- **Konu takvimi yap:** Örneğin 1. hafta el hijyeni (çocuk) ve tuz kısıtlaması (yetişkin); 2. hafta diş sağlığı (çocuk) ve diyabette ayak bakımı (yetişkin); 3. hafta ekran süresi (ergen) ve sigara bırakma (yetişkin); 4. hafta ergenlik ve menstrüel hijyen (ergen) ve akılcı ilaç kullanımı (yetişkin).
- **Plan bir kez, değerlendirme her kişi için:** Aynı konu farklı kişilere tekrar anlatılabilir; plan ve içerik bir kez hazırlanır ama her kişinin değerlendirmesi ayrı kaydedilir.
- **Eğitimi aynı gün kaydet:** Tarih, eğitim türü (çocuk-ergen/yetişkin), konu, kişinin baş harfleri, yaşı, cinsiyeti, yöntem, materyal, değerlendirme sonucu, Omaha kaydı numarası, fotoğraf numarası. Hafta sonunda her kategorinin toplam sayısını yaz.
- **Fotoğraf:** Kişiden **izin al**, çocuklarda **ebeveyn izni** al; mümkünse yüzü göstermeyen açılar (eller, maket, materyal); kimlik bilgisi, ekran ve kayıt görünmesin; fotoğrafları sosyal medyada paylaşma.

---

9. KONU BANKASI – ANAHTAR MESAJLAR

Aşağıda ASM'de en sık eğitim yapacağın konular ve her konuda vermen gereken temel mesajlar var. İki sayfalık içeriklerini bu mesajlardan hazırlayabilirsin.

9.1 Çocuk ve ergen konuları

El hijyeni

- Mikroplar gözle görülmez; ellerimizle ağzımıza, gözümüze ve başkalarına geçer.
- El yıkama zamanları: tuvaletten sonra, yemekten önce ve sonra, oyundan ve teneffüsten sonra, öksürüp hapşırdıktan ve burnu sildikten sonra, hayvanlara dokunduktan sonra, eve gelince.
- Yedi adım: elleri ıslat ve sabunla → avuç içlerini ovala → el sırtlarını ovala → parmak aralarını ovala → başparmakları döndürerek ovala → parmak uçlarını ve tırnakları avuç içinde ovala → bileklere kadar durula ve temiz havluyla kurula. Toplam en az 20 saniye (iki kez "iyi ki doğdun" şarkısı kadar).
- Öksürürken ve hapşırırken ağzı mendille ya da dirsek içiyle kapat.

Ağız ve diş sağlığı

- Dişler **günde iki kez** (sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce) **en az iki dakika** fırçalanır.
- Florürlü diş macunu: 3 yaşından küçüklerde pirinç tanesi, 3–6 yaş arasında bezelye tanesi, daha büyüklerde fırçanın yarısı kadar; macun yutulmaz, ağız çok çalkalanmaz.
- Fırçalama: Fırça diş etine 45 derece açıyla tutulur, küçük dairesel hareketlerle tüm yüzeyler (dış, iç, çiğneme yüzeyleri) ve dil temizlenir.
- Şekerli ve yapışkan yiyecekler (şeker, çikolata, cips, gazlı içecekler) çürüğe yol açar; özellikle öğün aralarında ve yatmadan önce tüketilmemelidir.
- Diş fırçası 3 ayda bir değiştirilir; diş hekimine 6 ayda bir gidilir. Altı yaş azı dişleri süt dişi değildir, korunmalıdır.

Sağlıklı beslenme

- **Kahvaltı** günün en önemli öğünüdür; kahvaltı yapan çocukların dikkati ve ders başarısı daha iyidir.
- Her gün **sebze ve meyve** (günde en az 5 porsiyon), tam tahıllı ekmek, süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt, peynir, ayran), et-tavuk-balık-yumurta-baklagiller.
- **Su** en iyi içecektir; gazlı ve şekerli içecekler, hazır meyve suları, enerji içecekleri yerine su, ayran, süt.
- Cips, çikolata, şekerleme, fast food, paketli atıştırmalıkları sınırla.
- Ekran karşısında yemek yememek; ailece sofraya oturmak.
- Sağlıklı tabak: tabağın yarısı sebze-meyve, dörtte biri tam tahıl, dörtte biri protein kaynağı, yanında bir süt ürünü.

Fiziksel aktivite

- Çocuklar ve gençler **her gün en az 60 dakika** orta ya da yüksek şiddette hareket etmelidir (koşmak, top oynamak, ip atlamak, bisiklet, dans, yüzme).
- Haftada en az 3 gün kas ve kemikleri güçlendiren etkinlikler (zıplama, tırmanma).
- Uzun süre oturmayı her saat birkaç dakika kalkıp hareket ederek bölmek.

Ekran süresi ve dijital denge

- 2 yaşından küçüklere ekran önerilmez; 2–5 yaş arasında günde en fazla 1 saat; okul çağında eğlence amaçlı ekran süresinin sınırlı tutulması (genellikle 2 saatin altında) önerilir.

- Yatmadan en az 1 saat önce ekran bırakılmalı; telefon yatak odasında olmamalı.
- Uzun ekran kullanımı uykuyu, gözleri, duruşu, kiloyu ve ders başarısını olumsuz etkiler.
- İnternette tanımadığın kişilerle kişisel bilgi ve fotoğraf paylaşma; seni rahatsız eden bir şey olursa bir yetişkine söyle; siber zorbalığı bildir.

Uyku hijyeni

- Önerilen uyku süreleri: 6–12 yaş 9–12 saat, 13–18 yaş 8–10 saat.
- Her gün (hafta sonu dahil) aynı saatte yatıp kalkmak; yatmadan önce ekran, çay, kahve, kola, enerji içeceği yok; karanlık, sessiz ve serin oda.

Ergenlik dönemi değişiklikleri

- Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir; boy hızla uzar, beden değişir, duygular yoğunlaşır – bunlar **normaldir** ve herkeste farklı zamanda olur.
- Kızlarda meme gelişimi, kıllanma ve adet görme; erkeklerde testislerin büyümesi, ses kalınlaşması, sakal-bıyık, kıllanma.
- **Kişisel hijyen:** Her gün duş (özellikle terleme arttığı için), koltuk altı temizliği, temiz iç çamaşırı ve çorap, yüzün günde iki kez yıkanması; sivilceleri sıkmamak.
- Sorularını güvendiği bir yetişkine, ailesine ya da sağlık çalışanına sorabileceği.

Menstrüel (adet) hijyeni

- Adet görmek sağlıklı bir bedenin işaretidir; ilk yıllarda düzensiz olabilir.
- Ped **4–6 saatte bir** (kanama fazlaysa daha sık) değiştirilmeli; ped değiştirmeden önce ve sonra eller yıkanmalı; genital bölge önden arkaya doğru temizlenmeli; kullanılmış ped kâğıda sarılıp çöpe atılmalı (tuvalete atılmamalı).
- Adet döneminde banyo yapılabilir, normal etkinlikler ve hafif egzersiz sürdürülebilir.
- Ağrı için karına sıcak uygulama, hafif egzersiz; çok şiddetli ağrı, çok fazla kanama (saatte bir ped değiştirme), 7 günden uzun kanama, 15 yaşına kadar adet görmeme durumunda ASM'ye başvurulmalı.
- Demirden zengin beslenme (kırmızı et, yumurta, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler).

Akran zorbalığı

- Zorbalık; vurmak, itmek (fiziksel), alay etmek, lakap takmak (sözel), dışlamak, dedikodu yaymak (sosyal) ya da internette rahatsız etmek (siber) olabilir ve **tekrar eden** bir davranıştır.
- Zorbalığa uğrayan kişinin suçu yoktur; güvendiği bir yetişkine (aile, öğretmen, rehber öğretmen) söylemelidir.
- Zorbalığa tanık olan seyirci kalmamalı, arkadaşına destek olmalı ve bir yetişkine haber vermelidir.

Sigara, elektronik sigara, alkol ve madde

- Sigara ve elektronik sigara bağımlılık yapan nikotin içerir; ergenlerde bağımlılık daha hızlı gelişir.
- Kısa vadeli etkiler ergenler için daha etkileyicidir: nefes kokusu, sararan dişler, çabuk yorulma, spor performansının düşmesi, cilt sorunları, para kaybı.
- Elektronik sigara "zararsız" değildir.
- **Akran baskısına hayır deme becerisi:** Net bir "hayır" demek, gerekçe sunmak ("Sporu bırakmak istemiyorum"), konuyu değiştirmek, ortamdan ayrılmak, aynı düşünen arkadaşlarla birlikte olmak.
- Yardım hatları: ALO 171 (sigara bırakma), ALO 191 (madde bağımlılığı danışma).

Kazalar ve güvenlik

- Trafikte: yaya geçidinden ve ışıklarda karşıya geçmek, araçta emniyet kemeri ve çocuk koltuğu, bisiklette kask.
- Suda: gözetimsiz yüzmemek, bilinmeyen yerlerde suya girmemek.
- Evde: ilaçlar ve temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerde; prizlerle oynamamak; sıcak su ve ocaktan uzak durmak.
- Acil durumda **112**'yi aramak; zehirlenmede **114**.

Güneşten korunma

- Saat 10.00–16.00 arası doğrudan güneşten kaçınmak; şapka, güneş gözlüğü, ince uzun kollu giysi; açık alanlarda güneş kremi; bol su.

Kişisel güvenlik ve istismardan korunma (yaşa uygun dille)

- "Vücudum bana ait"; mayo ile örtülen yerlere kimse dokunamaz (sağlık kontrolünde ebeveyn yanındayken hekim/hemşire hariç).
- Kötü hissettiren dokunuşa "hayır" de, oradan uzaklaş ve güvendiğin bir yetişkine anlat.
- Kötü hissettiren **sırlar tutulmaz**; seni korkutsa bile anlatmalısın, suçlu sen değilsin.
- Tanımadığın kişilerle hiçbir yere gitme, onlardan hediye alma.

9.2 Yetişkin konuları

Hipertansiyon

- Yüksek tansiyon çoğu zaman **belirti vermez** ("sessiz katil") ama kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve görme kaybına yol açabilir.
- Kan basıncı en az yılda bir ölçtürülmelidir; 140/90 ve üzeri yüksektir.
- Tuz günde 5 gramın altında; sebze-meyve ağırlıklı beslenme; kilo verme; haftada en az 150 dakika yürüyüş; sigarayı bırakma; alkolden uzak durma; stres yönetimi.
- İlaçlar kendini iyi hissetse de **her gün aynı saatte** kullanılmalı, hekime danışmadan bırakılmamalı.
- Şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, görme ya da konuşma bozukluğu, kolda güçsüzlük → 112.

Diyabet

- Belirtiler: çok su içme, çok idrara çıkma, çok yeme, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk, yaraların geç iyileşmesi.
- Risk faktörleri: fazla kilo, hareketsizlik, ailede diyabet, gebelikte şeker öyküsü, yüksek tansiyon.
- Düzenli öğünler, porsiyon kontrolü, şekerli içecek ve tatlıların sınırlandırılması, tam tahıllar, sebze; düzenli egzersiz.
- Düşük şeker (70 mg/dl altı) belirtileri ve **15-15 kuralı**: 15 gram hızlı şeker al, 15 dakika sonra ölç.
- **Ayak bakımı:** Her gün ayakları kontrol et, ılık suyla yıka ve parmak aralarını kurula, tırnakları düz kes, çıplak ayakla yürüme, rahat ayakkabı giy, küçük yarada bile başvur.
- Yılda bir göz dibi, böbrek ve ayak kontrolü; 3–6 ayda bir HbA1c.

Sağlıklı beslenme ve obezite

- BKİ 25 ve üzeri fazla kilo, 30 ve üzeri obezitedir; bel çevresinin kadında 88, erkekte 102 cm'yi aşması kalp-damar riskini belirgin artırır.
- Sağlıklı tabak modeli; porsiyon kontrolü (küçük tabak, yavaş yeme); şekerli içecekler, hamur işleri, kızartmalar ve işlenmiş gıdaların azaltılması; günde 8–10 bardak su; öğün atlamamak.
- Gerçekçi hedef: 6 ayda mevcut kilonun %5–10'unu vermek.
- Diyetisyene ve Sağlıklı Hayat Merkezine başvurulabileceği.

Fiziksel aktivite

- Yetişkinler haftada **150–300 dakika orta şiddette** (tempolu yürüyüş) ya da **75–150 dakika yüksek şiddette** aktivite yapmalı; haftada en az **2 gün kas güçlendirme** egzersizi eklemeli.
- 65 yaş üstünde ayrıca **denge** egzersizleri (düşmeleri önler).
- Uzun süre oturmayı bölmek; asansör yerine merdiven; kısa mesafelere yürüyerek gitmek.

Sigara bırakma

- Sigarayı bırakmanın yararları hemen başlar: 20 dakika sonra nabız ve kan basıncı düşmeye başlar; birkaç gün içinde tat ve koku alma düzelir; birkaç hafta-ay içinde solunum rahatlar; bir yıl sonra kalp krizi riski belirgin azalır.
- Bırakma tarihi belirlemek, evdeki sigara ve küllükleri atmak, tetikleyicileri (çay-kahve sonrası, stres) tanıyıp alternatif davranışlar geliştirmek, aileden destek istemek.
- **ALO 171** sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma poliklinikleri; ilaç desteği için hekime başvuru.
- Pasif içicilik çocuklarda astım, orta kulak enfeksiyonu ve ani bebek ölümü riskini artırır; ev ve araç **dumansız** olmalı.

Aile planlaması

- İki doğum arasında **en az 2 yıl** bırakmak anne ve bebek sağlığını korur.
- Yöntemler: kondom, hap, iğne, implant, rahim içi araç (spiral), tüp ligasyonu, vazektomi; doğum sonu dönemde emzirmeyle uyumlu yöntemler.
- Yöntemlerin ASM'de ücretsiz danışmanlık ve uygulama olanakları; yanlış inanışların düzeltilmesi.
- Korunmasız ilişki sonrası **acil kontrasepsiyon** için hemen sağlık kuruluşuna başvurulabileceği.

Menopoz ve osteoporoz

- Menopoz, adetlerin bir yıl boyunca hiç görülmemesiyle tanımlanır; genellikle 45–55 yaşlarında olur. Sıcak basmaları, terleme, uyku sorunları, duygu durumu değişiklikleri, vajinal kuruluk görülebilir.
- Baş etme: hafif giyinme, serin ortam, düzenli egzersiz, kafein ve baharatı azaltma, stres yönetimi; şikâyetler yoğunsa hekime başvurma.
- Osteoporoz (kemik erimesi) riskine karşı: süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin beslenme, güneş ışığından yararlanma ve D vitamini (hekim önerisiyle), **yük bindiren egzersizler** (yürüyüş), sigara ve alkolden uzak durma, düşmeleri önleme.
- Menopozdan sonra vajinal kanama olursa mutlaka hekime başvurulmalı.

Akılcı ilaç kullanımı

- **Antibiyotikler virüslere etki etmez**; grip ve soğuk algınlığının çoğu virüslerle olur ve antibiyotik gerekmez.
- Antibiyotikler yalnızca hekim önerisiyle, önerilen doz ve sürede kullanılmalı, iyileşince yarıda bırakılmamalı.
- İlaçlar başkasıyla paylaşılmamalı, başkasının ilacı kullanılmamalı.
- Kullanılan tüm ilaçlar (bitkisel ürünler dahil) hekime söylenmeli.
- İlaçlar orijinal kutusunda, serin ve kuru yerde, çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalı; son kullanma tarihi geçmiş ya da artan ilaçlar eczanelerdeki **ilaç atık kutularına** atılmalı.

Erişkin aşıları

- Td (tetanoz-difteri) aşısı 10 yılda bir.
- 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar her yıl sonbaharda **grip aşısı**, ayrıca **pnömokok** aşısı.
- Gebelikte Td aşısının önemi.

Ruh sağlığı ve stres

- Stres belirtileri: uyku sorunları, sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, odaklanma güçlüğü.
- Baş etme: düzenli uyku, hareket, nefes ve gevşeme egzersizleri, sevdiği etkinliklere zaman ayırma, sosyal destek, sorunları paylaşma.
- İki haftadan uzun süren mutsuzluk, umutsuzluk, ilgi kaybı → hekime başvurma. Kendine zarar verme düşüncesi varsa **hemen** yardım istenmeli (112).

Afete hazırlık

- Ailece **afet planı:** buluşma yeri, iletişim kişisi, toplanma alanının öğrenilmesi.
- **Afet ve acil durum çantası:** su, uzun ömürlü yiyecek, ilk yardım malzemesi, düzenli kullanılan ilaçlar, el feneri, pil, düdük, önemli belgelerin kopyaları, battaniye.
- Depremde **"Çök – Kapan – Tutun"**; eşyaların duvara sabitlenmesi.

Gıda güvenliği

- Yemek hazırlamadan önce ve çiğ etle temastan sonra el yıkama; çiğ ve pişmiş gıdaları ayrı tutma (ayrı kesme tahtası); gıdaları iyice pişirme; pişmiş yemeği oda ısısında 2 saatten fazla bekletmeme; buzdolabını 4 °C'nin altında tutma; güvenli su kullanma.

Emzirme ve bebek bakımı (yetişkin eğitimi olarak anneye/aileye)

- İlk 6 ay yalnızca anne sütü; doğru tutuş ve kavrama; bebeğin isteğine göre sık emzirme; yeterli süt belirtileri; 6. aydan sonra ek gıda ile birlikte 2 yaşına kadar emzirme.
- Güvenli uyku (sırtüstü, sert yatak, yatakta yumuşak eşya yok, dumansız ortam); bebeği asla sarsmama; D vitamini ve demir desteği; aşılar; bebekte tehlike belirtileri.

Yaşlılarda düşmeleri önleme (yaşlıya ve bakım verene)

- Kaygan halıları kaldırma, gece lambası, banyoda tutunma barı ve kaydırmaz paspas, merdivenlerde tırabzan.
- Yataktan yavaş kalkma; kaymaz tabanlı ve arkası kapalı terlik; gözlük ve işitme cihazı kullanma; düzenli denge ve kuvvet egzersizleri; ilaçların hekimce gözden geçirilmesi; telefonu yanında taşıma.

---

10. KENDİNİ TEST ET

1. Bir eğitimin konusunu seçerken eğitim gereksinimini hangi kaynaklardan belirlersin?
2. Eğitim öncesi kısa sağlık öyküsünde neleri sorarsın? Bu bilgiler eğitimi nasıl etkiler?
3. Sağlık okuryazarlığı nedir? Düşük sağlık okuryazarlığı olan bir kişiye eğitim verirken neye dikkat edersin?
4. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlar için birer hedef yaz. Hangi fiiller kullanılmaz?
5. Yetişkin eğitiminin ilkelerini say. Çocuk ve ergen eğitiminden farkı nedir?
6. Sağlık İnanç Modeli'nin bileşenlerini, ilacını düzensiz kullanan bir hasta üzerinden açıkla.
7. Transteorik modelin aşamaları nelerdir? Her aşamada nasıl bir eğitim yaparsın?
8. Beceri öğretiminde en etkili yöntem ve materyal hangisidir?
9. İyi bir broşürün özellikleri nelerdir? "En fazla 2 sayfalık içerik" nasıl yazılır?
10. Sağlık eğitim planının bölümlerini say.
11. Bir eğitimin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde neler yapılır?
12. Öğret-geri al yöntemi nedir, neden kullanılır?
13. Bir eğitimi hangi yöntemlerle değerlendirirsin?
14. "Haftada en az 15 kişi" kuralını çocuk-ergen ve yetişkin eğitimleri için nasıl tutturur ve kanıtlarsın?
15. Diş fırçalama, menstrüel hijyen, ekran süresi, tuz kısıtlaması, sigara bırakma ve akılcı ilaç kullanımı konularında ikişer anahtar mesaj söyle.